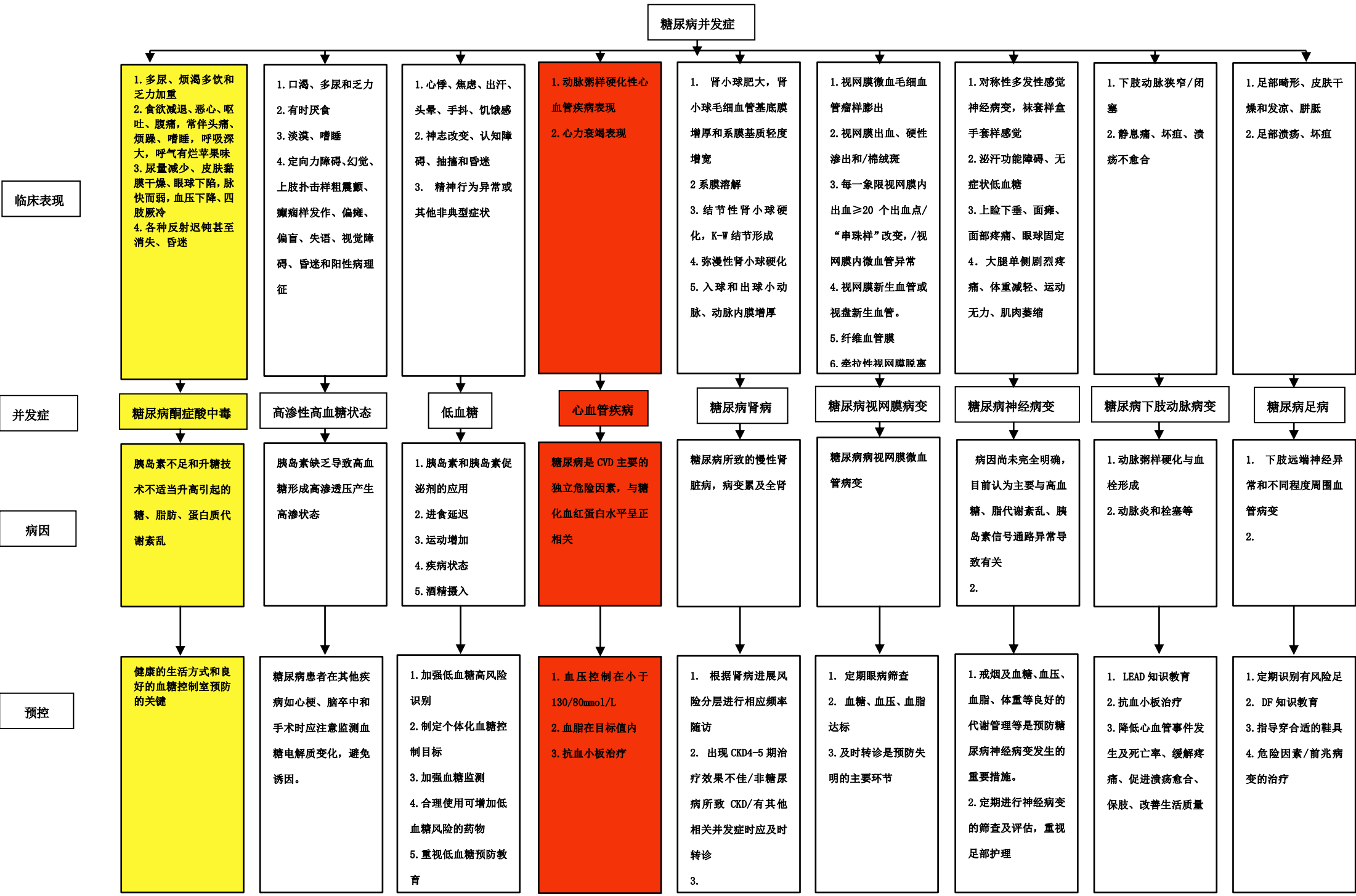


糖尿病并发症预控预警地图



应急处理

- 1. 补液：纠正失水
- 2. 皮下/静脉使用胰岛素
- 3. 纠正电解质紊乱
- 4. 纠正酸中毒
- 5. 去除诱因和治疗并发症
- 6. 监护、吸氧
- 7. 加强基础护理
- 8. 心理护理

- 1. 补液：纠正脱水
- 2. 小剂量胰岛素静脉治疗控制血糖
- 3. 纠正水、电解质和酸碱失衡
- 4. 去除诱因和治疗并发症
- 5. 必要时可行连续性肾脏替代治疗

- 1. 意识清楚者口服 15-20 克糖类食品
- 2. 识障碍者予 50%葡萄糖 20-40ml 静注/胰高糖素 0.5-1.0mg 肌注
- 3. 每 15 分钟监测 1 次血糖，若血糖 < 3.9mmol/L 再次葡萄糖口服/静注；血糖 > 3.9mmol/L, 但距下一餐 1h 以上是予含淀粉/蛋白质食物；血糖 < 3.9mmol/L, 继续予 50%葡萄糖 60 毫升静注
- 7. 低血糖纠正后了解原因调整用药实施相关教育
- 8. 低血糖为纠正则继续静注葡萄糖，意识恢复后至少监测 24-48h

- 1. 血压控制目标个体化
- 2. 根据动脉粥样硬化性心血管疾病风险等级高低将 LDL-C 降至目标值
- 3. 应用阿司匹林作为二级预防
- 4. 联合抗凝和抗血小板治疗减少心血管缺血事件

- 1. 改变不良生活方式
- 2. 营养干预
- 3. 控制血糖、血压、血脂
- 4. 使用非甾体类盐皮质激素受体拮抗剂
- 5. CKD 相关并发症评估及肾脏替代治疗

- 1. 健康教育，DR 早防早治
- 2. 控制代谢紊乱
- 3. 针对 DR 进行内科治疗：如改善微循环
- 4. 眼科治疗：激光光凝术

- 1. 针对病因及发病机制治疗
- 2. 疼痛管理：药物/非药物治疗
- 3. DAN 治疗：停用/减量加重直立性低血压的药物，充分饮水，高钠饮食

- 1. 明确严重肢体缺血
- 2. 可行血运重建者行影像学检查择期行血运重建
- 3. 不可行血运重建者病灶和疼痛稳定的可药物、脊髓刺激/干细胞移植治疗；疼痛不可耐受、感染扩散者截肢

- 1. 评估 DFU 性质加强护理
- 2. 合理降糖降压调脂和抗血小板治疗
- 3. 积极治疗糖尿病性 LEAD
- 4. 合理选择抗生素治疗
- 5. 合理进行 DFU 局部处理
- 6. 重视足溃疡减压治疗
- 7. 辅助使用物理治疗
- 8. 手术治疗
- 9. 技术及时会诊与转诊